



Le recours à l'HAD de l'AP-HP

Louisemarine.harle@aphp.fr

06 30 55 58 05

Indications et organisation de l'HAD

Dr Louise Harlé - gériatre HAD AP-HP

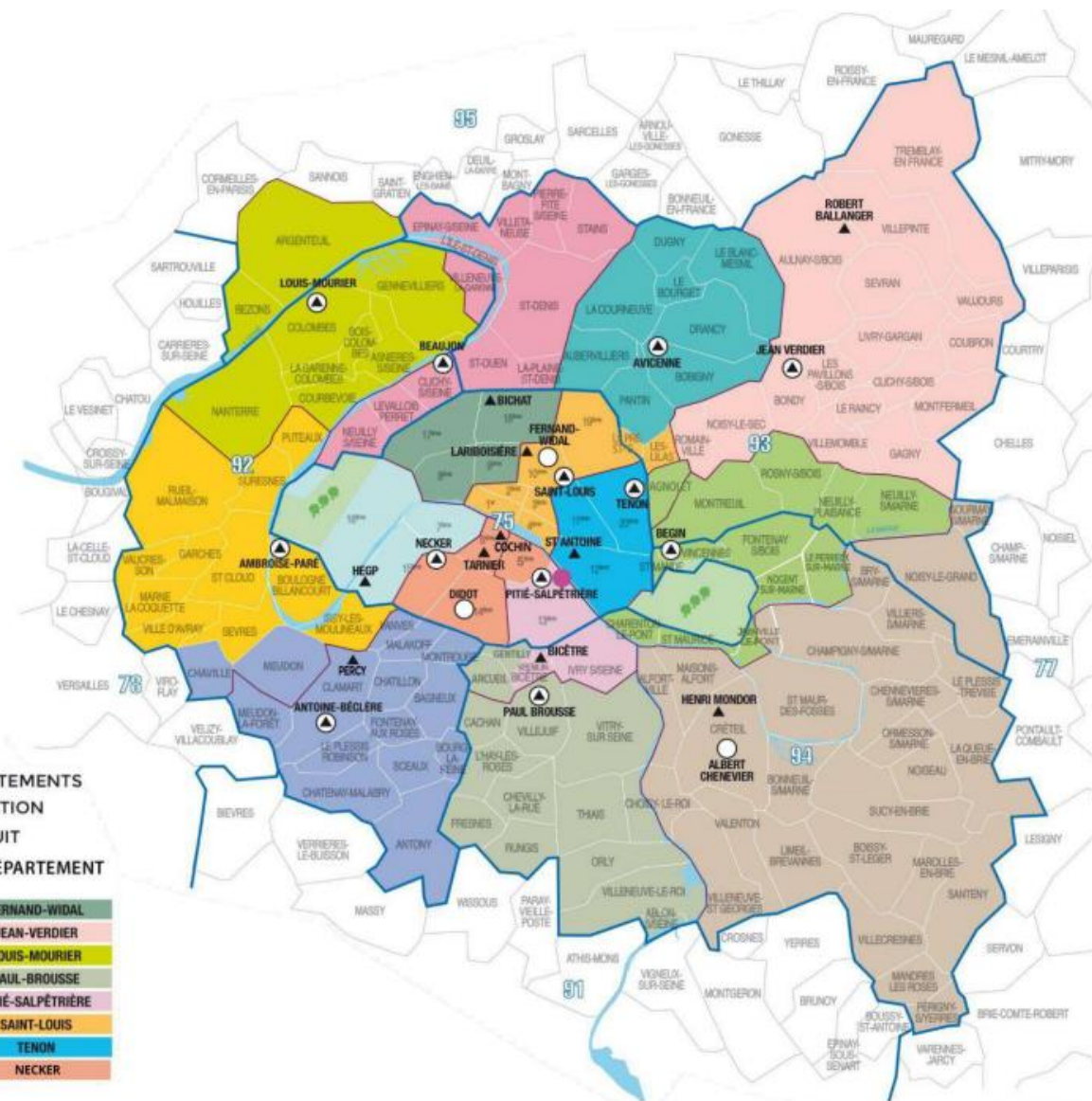
30 septembre 2026



L'HAD AP-HP



- Hôpital de l'AP-HP
- Territoire d'intervention : Grand Paris (75, 92, 93, 94, sud 95 et nord 91) avec organisation en unités de soins de proximité
- Offre de soins intensité et technicité 24/24 et 7/7 avec une coordination clinique de proximité
- Polyvalence de l'activité : 830 patients jour avec enfants (120), obstétrique (90), adultes (620) avec forte activité gériatrique (50% patients ont plus de 75 ans)
- Patients au domicile



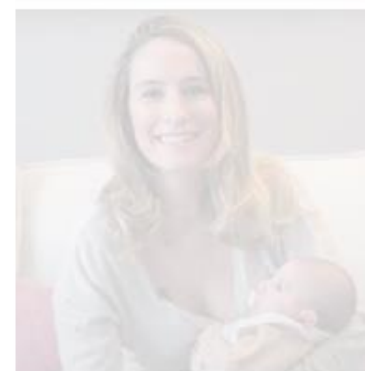
Etablissement
santé

de



■ Pour les adultes

- ▶ Les soins palliatifs
- ▶ La chimiothérapie anticancéreuse
- ▶ La surveillance post-chimiothérapie
- ▶ La post-radiothérapie
- ▶ Les pansements complexes et soins spécifiques
- ▶ Le post-traitement chirurgical
- ▶ Les traitements intraveineux
- ▶ L'injection de toxine botulique
- ▶ L'assistance respiratoire
- ▶ L'éducation du patient et de son entourage
- ▶ La nutrition parentérale
- ▶ La nutrition entérale
- ▶ La rééducation
- ▶ La prise en charge psychologique et sociale
- ▶ La prise en charge de la douleur
- ▶ ...



Etablissement
santé de



Patients
gériatriques en
HAD

Quels patients gériatriques pour l'HAD AP-HP?

Population cible

- Patients de plus de 75 ans, stables cliniquement,
- Ayant des incapacités fonctionnelles modérées à sévères
- Nécessitant l'intervention d'au moins 2 intervenants professionnels (ergothérapeute, diététicien, assistante sociale, psychologue)
- Patient ayant un domicile avec une prise en charge sociale déjà initiée

Critères d'exclusion

- Patient âgé isolé + troubles cognitifs et en incapacité d'alerter en cas d'urgence
- Patients non stabilisés ayant besoin de surveillance intensive
- Patient sans domicile
- Patient sans sécurité sociale et sans assurance

Coordination de plusieurs professionnels de santé

Objectif : Maintien au domicile pérenne

Territoire de l'HAD: 75,92; 93; 94;



Intervention de l'HAD

- L'HAD c'est
 - Equipe IDE et AS
 - Equipe pluridisciplinaire : diet, psy, ASE, ergo
 - Astreinte médicale téléphonique 24h/24.
 - Equipe de nuit en présentiel de 21h à 7h
- Pas de présence soignante 24h/24 au domicile

Modalités



Exemple HAD pansement complexe

Escarre stade IV du sacrum

Objectif des soins

Plusieurs intervenants

- . Évaluation pluridisciplinaire
- . Suivi équipe plaie si besoin
- . IDE
- . AS

Réévaluation antalgique



Exemple HAD antibiothérapie

Antibiothérapie à réserve hospitalière

Passage IDE

Suivi clinique et bio

+/- autres intervenants

Suivi médical

Fin d'HAD à la fin de l'antibiothérapie

Exemples



Exemple HAD palliative

Evaluation clinique du confort

Evaluation de l'environnement et des aidants

Charge en soins IDE et AS en fonction de l'état général du patient

PEC pluridisciplinaire

Sollicitation du médecin praticien d'HAD pour réévaluer les traitements

Projet de fin de vie : USP / Décès au domicile /transfert hospitalier



Admission en HAD

Contacts HAD

- Orbis demande d'admission en HAD
- Mail: had.adulte@aphp.fr et même trajectoire

Admission en HAD

Les infirmiers de coordination se déplacent à votre rencontre

Une prise en charge rapide des patients présentant une détresse aiguë dans le cadre d'une démarche palliative.

- Binôme IDE-médecin intervenant dans les heures qui suivent une instabilité
- Souhait de rester au domicile
- Démarche palliative réfléchie collégialement et avec la possibilité de soins techniques rapides
- Avec délibération médicale initiale par téléphone entre médecin d'HAD et médecin au chevet (médecin SAMU), centrée sur l'avis du patient et de ses proches.
- L'équipe PALLIDOM accompagne ensuite les patients durant 48h à 72h, relais par une HAD classique en cas de stabilisation

Un médecin nous appelle (MT, SMUR, SOS, MedCo EHPAD, Réseau SP, Médecin Hospitalier)

Ligne médicalisée directe 24/7 : 01 73 73 54 86

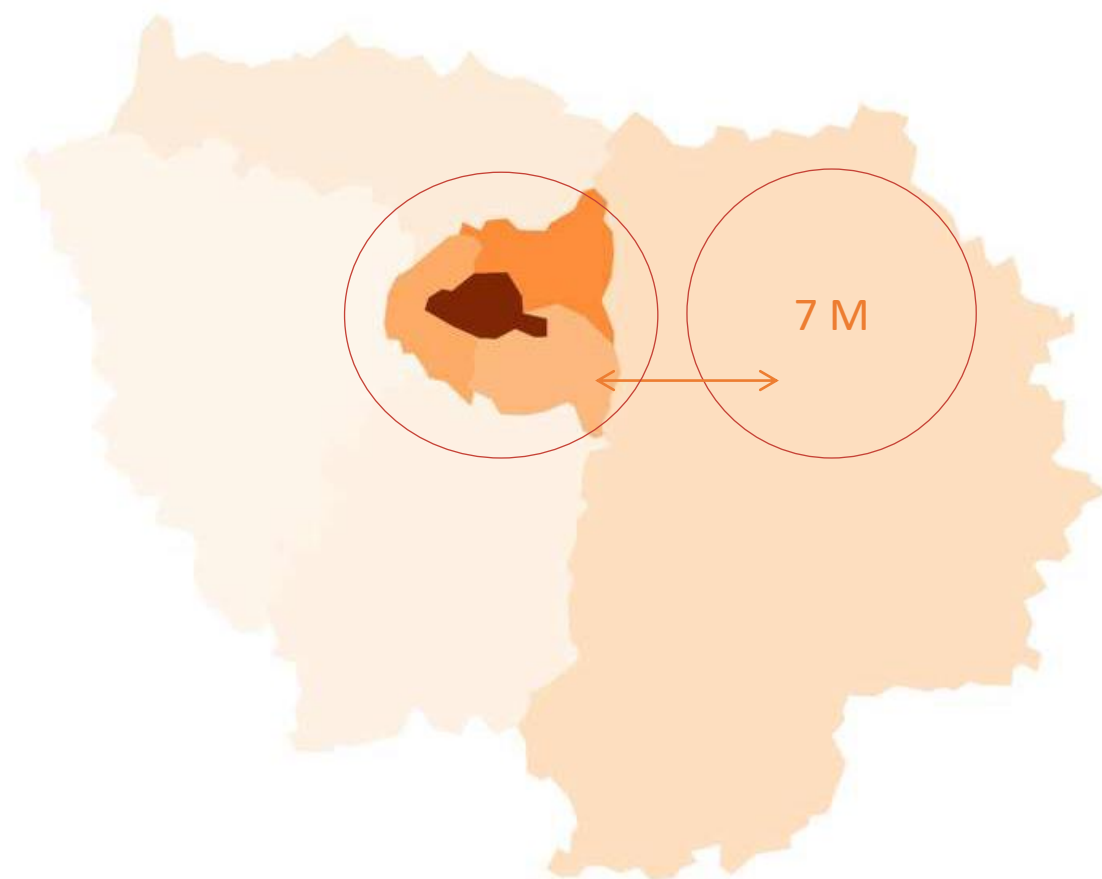
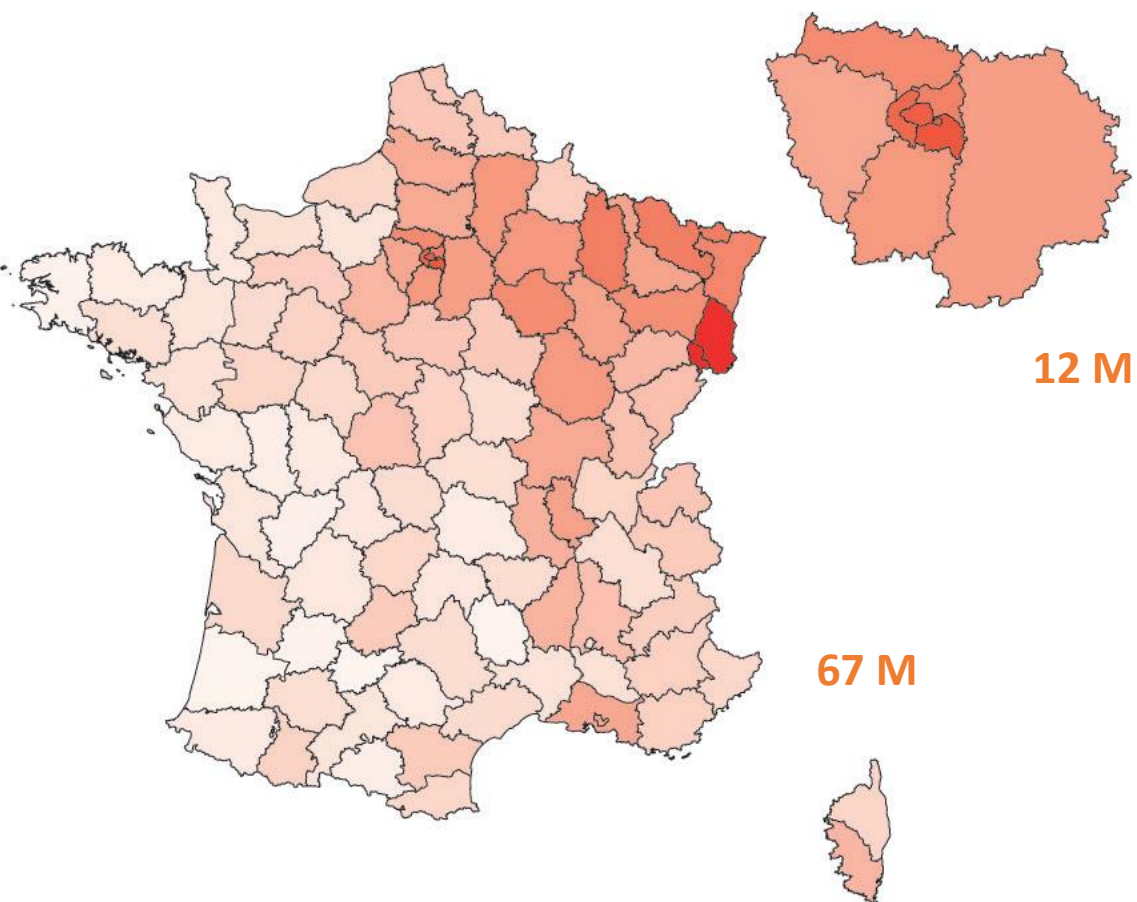
- 1ere étape : Appui à la collégialité :
 - Formalisation démarche palliative
 - Formalisation intérêt (et possibilité) du domicile
 - Formalisation intérêt PALLIDOM
- 2eme étape : Effectation :
 - Association de traitements curatifs peu invasifs et de traitements symptomatiques de confort
 - Accompagnement global phase initiale et suivi



PALLIDOM

Soins Palliatifs Aigus
à Domicile
HAD AP-HP

Un territoire complet depuis décembre 2023
75 + 92 + 93 + 94



Hospitalisation
à Domicile
AP-HP



PALLIDOM





Être médecin en HAD



- 1 médecin par territoire
- Staff pluridisciplinaire US
- VAD programmées avec cadre ou soignant
- Réévaluation clinique et prescriptions
- Staff médical cas complexes : regard de plusieurs spécialités médicales

Médecins en HAD

Une journée d'un médecin d'HAD

- 9h 📞
- 10h « On the road » 🏠 🚲
- Point d'équipe à Tenon 14h-15h 👤 👤
- Réévaluation téléphonique bios 📞 🖥️ 📞 🩺 📋
- 18h30 « off » 😊 ✨
- Urgences 🚑 , transferts hospitaliers 🚚 🏥 , réunions 💬 👤 👤



Expertise médicale en HAD

-  Médecin hospitalier au domicile
- **Nombreux spécialistes** Gériatrie oncologie hématologie infectiologie médecine interne
- **Expertise palliative** 
- **Organisation des soins au domicile** Ingénierie des parcours de soins complexes en HAD : concevoir en équipe pluriprofessionnelle des parcours de soins à l'interface des besoins des patients et des ressources du territoire



HAD - AP-HP

HAD AP-HP / EHPAD

MERCI DE VOTRE ATTENTION

Louise Harlé
Géiatre HAD AP-HP

louisemarine.harle@aphp.fr

30 septembre 2026